

Enfermedad Celiaca

Bibliográfica 2025 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Consenso SAP 2024

La EC es el resultado de la interacción de diferentes factores inmunológicos, genéticos y ambientales, desencadenada por péptidos llamadas prolaminas (**péptido de gliadina**) presentes en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena.

El factor genético es fundamental para el desarrollo de esta patología; se conoce que es un desorden multigénico asociado con **HLA-DQ2** o **HLA-DQ8**.

Prevalencia: (estudio 2012) 1:79 (1,26 %), predomina en mujeres, con una relación de 2:1 sobre el sexo masculino.

Formas clínicas

- **Forma sintomática clásica**

Más común en menores de 3 años edad.

Incluye síntomas relacionados a la malabsorción de nutrientes, déficit de vitaminas, minerales y/o micronutrientes. El síntoma más frecuente (50 % de los pacientes) es la diarrea crónica.

Crisis celíaca

Cuando el diagnóstico se retrasa, pueden presentar una crisis celíaca, con desnutrición grave por esteatorrea, hipoalbuminemia, edemas, hipocalcemia, tetania e hipopotasemia.

Tratamiento:

- Internación
- Corrección hidroelectrolítica (sodio y potasio)
- Aporte de minerales (hierro y calcio) y micronutrientes (zinc)
- Muy frecuentemente, se requiere una alimentación forzada con sonda nasogástrica con fórmulas especiales que sean sin lactosa y con caseína, o a base de hidrolizado proteico y con grasas en un 50% como triglicéridos de cadena media
- Casos refractarios: corticoides

- **Forma sintomática no clásica**

Se observan pacientes con un comienzo más tardío y con síntomas más leves e intermitentes.

Síntomas digestivos	Síntomas extradigestivos
Reflujo gastroesofágico Epigastralgia Diarrea recurrente Dolor abdominal Distensión abdominal Constipación	Talla baja (10 % de los pacientes) Anemia ferropénica Aftas recurrentes Defectos en el esmalte dental Hipertransaminasemia Retardo de la pubertad Fatiga crónica Cefalea Trastornos ginecológicos Dermatitis herpetiforme Osteopenia-osteoporosis Neuropatía Irritabilidad Artritis-artralgias

- **Forma asintomática o silenciosa**

Estos pacientes con serología positiva y atrofia vellositaria característica de EC que revierten con una dieta libre de gluten (DLG) son detectados en grupos de riesgo, o como hallazgo endoscópico o en la población general. Es más frecuente en familiares de

celíacos, que pueden cursar la enfermedad asintomática durante años, especialmente en niños mayores, adolescentes y adultos.

EC seronegativa: se define en pacientes con o sin síntomas, que presentan atrofia vellositaria, con HLA de riesgo, y todas las pruebas serológicas negativas, e IgA sérica total normal. Se confirma el diagnóstico, habiéndose descartado otras patologías, con buena respuesta clínica a la DLG y recuperación histológica en la biopsia de control. Existen distintas situaciones en las que los a-tTG pueden presentarse falsos negativos o con valores bajos: pacientes que hayan suspendido el gluten de su dieta, pacientes con déficit de IgA, pacientes menores de 2 años (menor respuesta inmune) y en pacientes con lesiones histológicas iniciales (Marsh 1).

- **Forma potencial**

Esta forma clínica se refiere a aquellos individuos con o sin síntomas, con serología positiva, que presentan una biopsia intestinal normal, con riesgo de desarrollar EC.

Grupos de riesgo

- Familiares de 1º grado de pacientes celíacos.
- Enfermedades autoinmunes
- Enfermedades genéticas como Síndrome de Down, Williams y Turner.
- Trastorno de inmunodeficiencia: déficit de IgA.

DIAGNÓSTICO

A. Pruebas serológicas

Prueba serológica de primera elección:

- Antitransglutaminasa IgA (a-tTG IgA)
- IgA sérica total (para evitar falsos negativos).

Los anticuerpos a-tTG clase IgG no son recomendados en el estudio inicial en el paciente con IgA normal porque tienen en general mayor variabilidad que los de clase IgA.

En pacientes con déficit de IgA (< de 7 mg/dl) solicitar anticuerpos a-tTG IgG o antipéptidos desaminados de gliadina IgG (a-PDG IgG).

La interpretación de resultados de a-tTG IgA determinada por ELISA o QLM debe ser diferente, a pesar de tener valor de corte semejante.

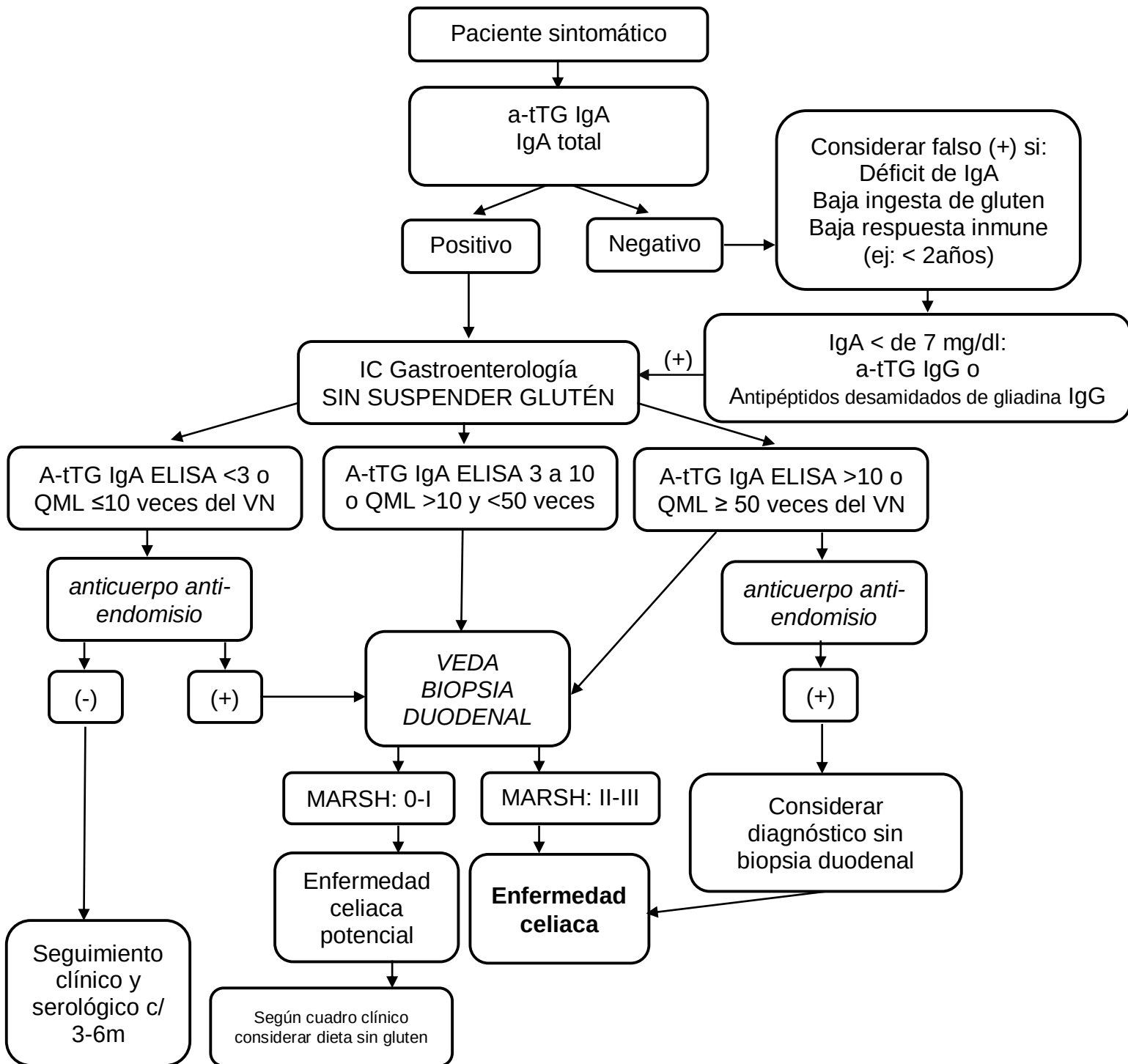
Por el método de QLM, los resultados muestran valores mucho más elevados que los obtenidos por ELISA.

ELISA tiene alto valor predictivo positivo (VPP) para atrofia vellositaria duodenal con valores $\geq$ de 10 veces el valor normal (VN) mientras que por QML un VPP semejante se alcanza con valores $\geq$ a 30 veces (VN).

No se recomienda la utilización de anticuerpos antigliadina (a-AGA) por su baja especificidad. Puede haber falsos positivos con frecuencia en pacientes con otras patologías digestivas como alergia alimentaria, giardiasis y enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn).

Falsos (+) de a-tTG IgA (con valores bajos): puede observarse en enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas, infecciones por el virus de Epstein-Barr. Especialmente pueden constatarse en el debut diabético (DBT tipo1) hasta 1 año posterior a este ("tormenta de anticuerpos"). La biopsia intestinal estará indicada por el gastroenterólogo evaluando el contexto clínico.

Algoritmo



B. Biopsia duodenal

En la videoendoscopia digestiva alta (VEDA), existen signos endoscópicos altamente sugestivos de EC, pero aproximadamente un tercio de los pacientes presentan lesiones en parches o apariencia endoscópica normal. Para un correcto diagnóstico, se deben tomar múltiples biopsias. Se recomienda al menos tomar 4 muestras de duodeno distal y 2 de bulbo.

Una biopsia intestinal normal en un paciente con sospecha clínica de EC y anticuerpos positivos puede estar relacionada a una ingesta baja de gluten antes de la biopsia, o a un error en la toma u orientación de las muestras.

El **diagnóstico** de EC se confirma con hallazgo de lesiones **Marsh 2-3**.

Aquellos pacientes con a-tTG IgA y a-EMA positivos, con biopsia normal, son considerados celíacos “potenciales” si presentan susceptibilidad genética. La **dieta libre de gluten** no debe indicarse a todos por igual; se debe categorizar y evaluar de acuerdo con la presencia de manifestaciones clínicas.

Acuerdo del 100 %.

Si el paciente es asintomático, no debe iniciar tratamiento, pero deberá tener un seguimiento clínico y analítico.

Clasificación histológica de Marsh-Oberhuber							
	Marsh 0	Marsh 1	Marsh 2	Marsh 3a	Marsh 3b	Marsh 3c	Marsh 4
ILE*	<30/100	>30/100	>30/100	>30/100	>30/100	>30/100	<30/100
							
Hiperplasia de criptas	-	-	+	+	+	+	-
Atrofia vellositaria	-	-	-	Aplanamiento parcial	Subtotal	Total	Total (atrófica hipoplástica)
ILE*: linfocitos intraepiteliales por cada 100 enterocitos							
No es celíaco pero debe seguirse ya que la atrofia es parcheada		ENFERMEDAD CELIACA					

B. Estudio genético HLA DQ2/DQ8

La determinación de HLA-DQ es de utilidad para excluir el diagnóstico de EC. Está indicado en pacientes que han iniciado una DLG sin haber confirmado el diagnóstico. En individuos pertenecientes a grupos de riesgo, permite seleccionar aquellos que deberán continuar con chequeos serológicos periódicos y en pacientes con enteropatía seronegativa. No se recomienda en el algoritmo diagnóstico inicial.

Complicaciones y pronóstico

Si el cumplimiento dietético es estricto, se ha comprobado que a los 10 años de la dieta el riesgo de enfermedades neoplásicas y probablemente también de enfermedades autoinmunes es similar al de la población general.

El pobre cumplimiento o las transgresiones dietéticas conllevan un riesgo especialmente de enfermedades neoplásicas del tracto digestivo, como carcinomas esofágicos y faríngeos, adenocarcinomas de intestino delgado y linfomas no Hodgkin.

Por otra parte, se ha observado que uno de cada 20 pacientes diagnosticados en la edad adulta desarrolla un linfoma de células T en los 4 años siguientes al diagnóstico.

Enfermedades no neoplásicas pero de gran morbilidad están también en relación con la enfermedad celíaca no tratada; así junto a enfermedades de tipo autoinmune, pueden observarse alteraciones del metabolismo óseo, problemas en relación con la reproducción, alteraciones neurológicas y psiquiátricas.

Una vez diagnosticada la EC los resultados deben quedar documentados en una constancia disponible en en la página <https://www.argentina.gob.ar/salud/celiaquia> y entregado al paciente. Esta debe incluir edad, clínica, serología e histopatología, para evitar dudas diagnósticas futuras y para el proceso de transición.

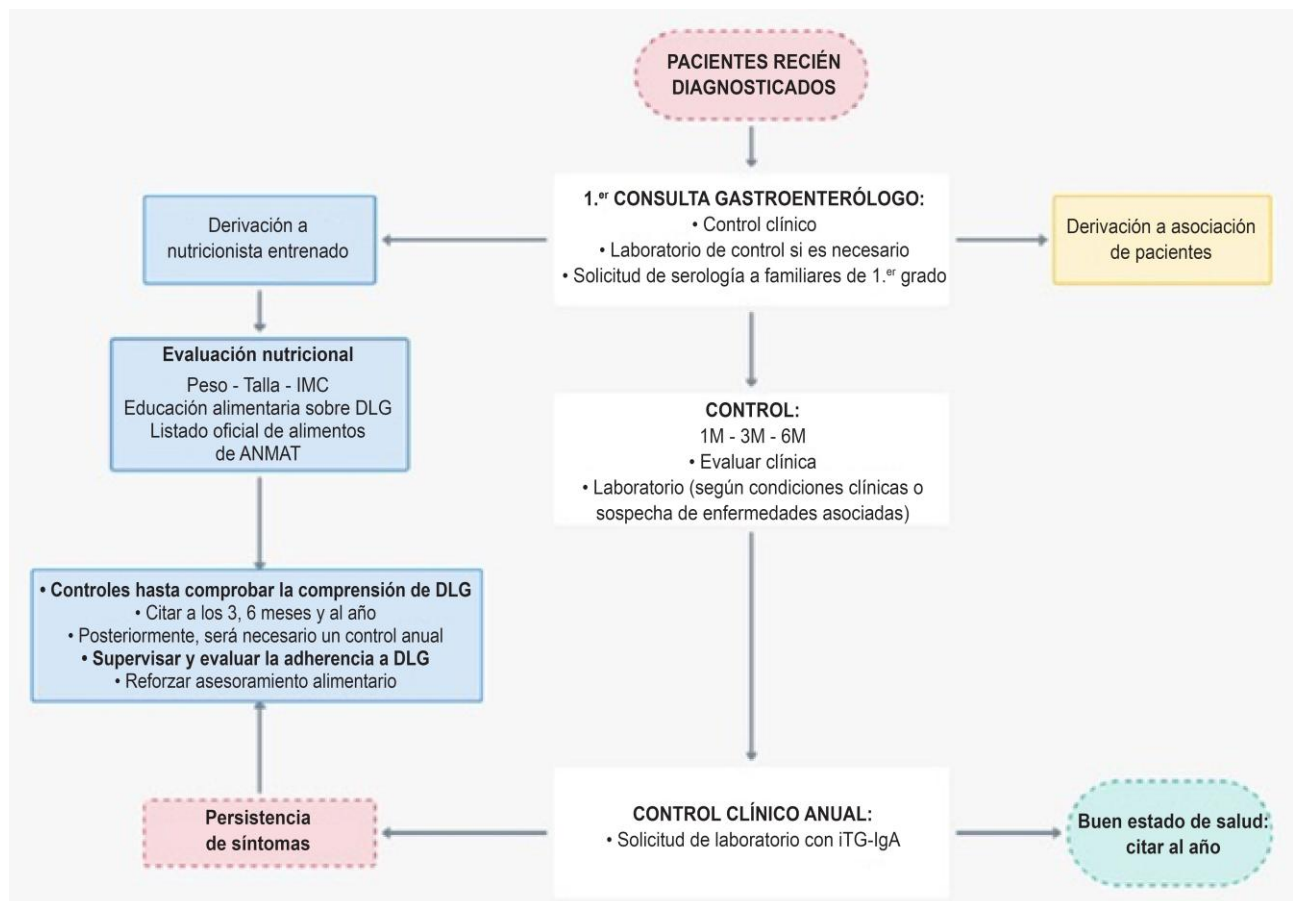
Controles

Deben ser más frecuentes en el primer año; las veces necesarias hasta la resolución de los síntomas, normalización del laboratorio y comprensión de la DLG. Luego cada 3 a 6 meses, hasta el año. Posteriormente, anual o bianual.

Serología: Anti-tTG IgA entre 6 meses y 1 año del tratamiento. Sus títulos disminuyen, pero requieren hasta 2 años para normalizarse. Cuando se utiliza el método de quimioluminiscencia (QML), los anticuerpos declinan más lentamente sin que signifiquen transgresiones.

Los títulos persistentemente elevados o la subsecuente positividad revelan ingesta significativa de gluten.

Control de laboratorio a familiares de 1º grado: aun asintomáticos, que estén consumiendo gluten. En los niños, a partir de los 2 años. Repetir cada 2 a 3 años



Tratamiento

El tratamiento consiste en la exclusión de cuatro cereales (trigo, avena, cebada y centeno), sus derivados y productos que los contengan de por vida.

La avena probablemente no ejerce un efecto nocivo por sí misma; sin embargo, muchos productos que la contienen pueden estar contaminados con gluten y se desconoce sus efectos a largo plazo.

Con ello se consigue la mejoría de los síntomas aproximadamente a partir de las dos semanas, la normalización serológica entre los 6 y 12 meses

La recuperación de las vellosidades intestinales se produce en > de 2 años de iniciado el tratamiento. Por ello, en algunos casos, puede ser necesario excluir temporalmente la lactosa de la dieta, hasta la recuperación de las enzimas de la pared intestinal. Igualmente y dependiendo del grado de malabsorción y/o de malnutrición del paciente, el tratamiento dietético inicial puede ser necesario el recomendar una dieta hipoalergénica, hipercalórica o pobre en fibra.

Al momento del diagnóstico, las deficiencias nutricionales más frecuentes son de hierro, calcio, zinc, vitaminas D, B12 y ácido fólico, por lo cual deberán ser suplementadas. La anemia ferropénica es muy frecuente y debe ser suplementada con hierro oral además de la DLG.^{20,21} La malabsorción de calcio y vitamina D puede causar dificultad para alcanzar el pico de masa ósea en la pubertad y causar mayor riesgo de osteoporosis

Grupo Alimenticio	Alimentos permitidos
Cereales	Granos de arroz y de maíz de cualquier marca envasados; harinas de mandioca, de papa, de soja y sus derivados envasados y demarcas permitidas, como así también premezclas elaboradas con harinas permitidas.
Verduras y frutas	Todos los vegetales y frutas frescas ó congeladas en su estado natural y aquellas envasadas que se encuentren dentro del listado de alimentos para celíacos.
Leche líquida	De todas las marcas
Leche en polvo, yogurt y quesos	Aquellos incluidos en el listado de alimentos aptos para celíacos.
Carnes y huevos	Todas las carnes (de vaca, ave, cerdo, cordero, conejo, pescados, mariscos, vísceras, liebre, cabra, vizcacha, peludo, etc.) y huevos. Con respecto a los fiambres y embutidos, se recomienda consumir sólo aquellos incluidos en el listado de alimentos
Aceites y grasas	Todos los aceites, manteca y crema de leche de todas las marcas.
Maníes, almendras, nueces y semillas	Elegir aquellas con cáscara y/o envasadas para evitar la contaminación cruzada con alimentos que contengan gluten.
Azúcar y miel pura	De todas las marcas
Dulces, golosinas, Amasados de pastelería, galletitas	Se recomienda consumir solamente aquellos que se encuentren en el listado de alimentos aptos para celíacos.
Agua	Es fundamental el consumo de aproximadamente 2 litros de agua potable / día
Bebidas gaseosas azucaradas	Se recomienda consumir libremente aquellas que sean de marcas líderes, para el resto se recomienda consultar el listado de alimentos aptos.
Café de grano molido	Se podrá consumir libremente.
Condimentos	Pueden contener gluten por eso se recomienda cultivar hierbas frescas, elegir pimienta en grano, azafrán en hebras o bien elegir aquellos que estén detallados en el listado de alimentos aptos

Se considera de suma importancia que la estrategia de tratamiento incluya la educación del equipo de salud, de la comunidad y el trabajo multidisciplinario con la inclusión de un Licenciado en Nutrición experto en EC y apoyo psicológico desde el inicio de la dieta libre de gluten.